

73a.

VERA TIYOMI NAGASHIMA

MEDICAMENTOS:	Elaupiril / Rox / Diamiron / Vesina		
SINTOMAS/QUEIXAS	Sonolência / Irritabilidade / Rebulos		
BANHEIRO			
HORA QUE ACORDA	6	Susta 1h	
HORA QUE DORME	23		
PRATICA EXERCICIO			

CAFE:	HORARIO DAS REFEIÇÕES		
29/06 P: 4-7cm H2O	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:
22	Maise Nzo S. - fua		

20/08 / Ela não estava utilizando devido ajuste max
 24 } TROCO o filtro
 água destilada fua



HOSPITAL PAULISTA

PHILIPS
RESPIRONICS

Nome:

VERA TIYOMI NAGASHIMA

Conclusão:

- 1- Sono fragmentado por despertares breves, com eficiência normal = 97.2%; (eficiência normal > 85%);
- 2- Redução da latência do sono, 1.1 minutos (normal >10 e < 30 minutos) e do sono REM, 52.5 minutos (normal = 70-120 minutos);
- 3- Redução da porcentagem do sono Delta = 4.9% (normal >13%);
- 4- Registraram-se 440 microdespertares (duração < 15 segundos), com índice de 63.4 /hora (normal <10/hora);
- 5- Aumento acentuado do índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 62.0/hora, com característica obstrutiva, com dessaturação da oxihemoglobina associada as apnéias (min. SaO2 =75 %);
- 6- Registro de ronco durante o período de sono.

Exame sugestivo de apnéia obstrutiva grau acentuado

IAH: 05-15 /hora leve

IAH: 15-30 /hora moderada

IAH: >30 /hora acentuada

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores

Dr. Braz Nicodemo Neto
(medicina do sono/otorrino)
crm 70179

Dra Anna K Smith
(medicina do sono/neuro)
crm 77842

Dra Zeni da Rocha Silva
(medicina do sono/neuro)
crm 82517

Nome: VERA TIYOMI NAGASHIMA

Data de Nascimento: 3-3-1955

IMC: 29,17

Sexo: Feminino

Data do exame: 04-05-2022

Peso: 71 kg

Altura: 1,56 m

Médico: DR. ADRIANO B. MAZER

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 04-05-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 512,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 12,0 e 114,0 minutos. O tempo total de sono foi de 433,0, eficiência de 84,6% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,1%; estágio N2: 56,8%; estágio N3: 19,1%; sono REM: 22,1%. O índice de despertares foi de 7,7/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 3,9/hora, sendo elas 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 28 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 88%, permanecendo 0,7% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 64 - 85 bpm e NREM de 65 - 86 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (14), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono normais;
4. número de despertares breves normal;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (0,6/hora);
7. registro de ronco intenso durante o sono.

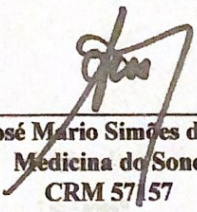
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 11,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57